

BILET DE IESIRE / SCRISOARE MEDICALA

Nr. contract/conventie:
VII/SP/22

FO: 16628

Nume:	Domiciliu: Loc.	Data internare: 23/04/2026 10:06
C.N.P:	Jud:	Data externare: 23/04/2026 14:21
Data nastere:	Strada:	Sectia: ONCOLOGIE
Varsta: Sex:	Nr:	Medic:
Grup sangvin: RH:	Alergii: NU CUNOASTE	

Diagnostic: Melanom malign cutanat braf mutant pt2n0(0+/3 GS)m0 braf mutant st. I B op., tratat adjuvant cu IFN alfa (2010). det sec subcutanate, osoase, hepatice. imunoterapie nivolumab + ipilimumab x 4 cu Remisiune completa, apoi Nivolumab de intretinere. Hipofizita autoimuna G1.

Investigatii efectuate:
Buletin 23/04/2026 :
Hemoleucograma completa:[(WBC) Leucocite=5.79 10⁹/L, Neutrofile %=56.7 %, Monocite %=7.8 %, Eosinofile %=10.0 %, Basofile %=1.3 %, Limfocite %=24.2 %, Neutrofile #=3.28 10⁹/L, Monocite #=0.45 10⁹/L, Eosinofile #=0.58 10⁹/L, Basofile #=0.08 10⁹/L, Limfocite #=1.40 10⁹/L, (RBC) Hematii=4.28 10¹²/L, (HGB) Hemoglobina=12.9 g/dL, (HCT) Hematocrit=38.2 %, (MCV) Volum mediu eritrocitar=89.3 fL, (MCH) Hemoglobina eritrocitara medie=30.1 pg, (MCHC) Concentr. medie de hemoglob. eritrocitara=33.8 g/dL, *(RDW-CV) Coef de variatie al indicelui de ditributie al eritrocitelor=12.7 %, (RDW-SD) Indice de ditributie a eritrocitelor=41.8 fL, (PLT) Trombocite=155 10⁹/L, (PDW) Indice de distributie a trombocitelor=17.1 fL, (MPV) Volum mediu trombocitar=12.1 fL, *(PCT) Placetocrit=0.188 %, *IMG%=0.1 %, *IMG#=0.01]
Bilirubina totala=0.626 mg/dL, Calciu seric total=9.31 mg/dL, Creatinina serica=0.58 mg/dL, Fosfataza alcalina=52.82 U/L, Glicemie=109.57 mg/dL, Potasiu seric=3.47 mmol/L, Sodiu seric=144 mmol/L, TGO/AST=22.34 UI/l, TGP/ALT=10.57 UI/l

Tratament:	Ciclul: 38	Acronim: Nivo q4w
-------------------	------------	-------------------

Grupa sange RH:	Tip	Nr pungii	Data
Epicriza: Pacienta in varsta de 76 de ani, diagnosticata in 2010 cu Melanom malign cutanat Breslow=1,5 mm (interscapulovertebral) op. pT2N0(0+/3 GS) M0 std I B, tratat cu adjuvant cu IFN timp de 2 luni (si intrerupt datorita toxicitatii), prezinta dupa un interval liber de aprox. 12 ani, in martie 2023, det. sec. cutanate, una fiind excizata, cu rezultatul HP : Det. sec de melanon malign, se prezinta pentru continuarea imunoterapiei. S-a analizat mutatia BRAF cu rezultatul: BRAF in exonul 15 s-a detectat mutatia activatoare BRAF V600E. PET CT (26.05.2023 - Medima): Concluzii: Multiple fixari focale FDG diseminate la nivel cutanat, limfo-ganglionar, osos si hepatic - inalt sugestive pentru det sec. RMN cerebral-M0. In cadrul CDIT se decide tratament cu Ipilimumab + Nivolumab x 4, cu reevaluare			

imagistica la 3 luni.

CT TAP (Oncohelp 01.09.2023): Pacienta in observatie oncologica pentru melanom malign operat, imunotratat. Lipsa iconografie anterioara. Modificari pulmonare in context inflamator/infectios la nivelul LMD, segmentelor latero- si posterobazal LID, segmente bazale LIS. Nodul pulmonar de 0.5 cm- segment anterior LSD. Adenopatii mediastinale. Noduli tisulari la nivelul partilor moi subtegumentar regiune retroscapulara stanga. Nodul tisular bine delimitat de 0.85 cm- mamar extern stanga.

Biologic: Cortizol seric (29.08.2023): 14.6 mmol, FT4 = 0,465 ng/dl, in rest HLB, probe renale, hepatice=N.

PET CT: - remisiune completa.

CT TAP (Medima): boala stationara.

19.04.2024 TSH=3,4210 mUI/L; FT4=1.00 ng/dl; cortizol seric= 0,46 ng/dl, DHEA-S=6,5 ug/dl;

CT Craniu 08.07.2024 - Medima): Imagine nodulara lacara, localizata cortical, la nivelul girusului F mijlociu stg - leziune sechelara - similar. Meningiom calcifiat F stang similar. Mica lacuna ischemica la nivelul hipocampului drept.

CT TAP (08.07.2024): Limfonoduli mediastinali - in regresie numerica si dimensionala. Litiaza veziculara. Cisturi corticale renale bilateral. Cate o imagine osteocondensanta, bine delimitata, localizata la nivelul corpilor vertebrali T5, T8, T10, similare - necesita monitorizare. Hernii Bochdalek. Glanda tiroida cu structura neomogena prin prezenta la nivelul LTS a 3 imagini nodulare hipodense - cvasisimilar cu examinarea anterioara - necesita corelare cu ecografia.

CT TAP (24.10.2024; Medima): Boala stationara.

CT TAP(28.01.2025, Medima): Boala stationara.

CT TAP(18.08.2025, Medima): Boala stationara.

CT TAP(17.02.2026, Medima): Boala stationara.

Actual, se prezinta pentru continuarea imunoterapiei

Clinic: IP= 0 ECOG, mentine RC.

Lab.- in limite normale

Se administreaza Nivolumab C38 in doze optimeale (Nivolumab 480 mg DT), cu toleranta acuta buna.

Recomandari: Se externeaza cu indicatiile:
! Pacientei i s-a emis brosură/card cu posibilele reactii adverse si tratamentul acestora;
-Repeta CT TAP in august 2026
-Revine pentru continuarea tratamentului in data de 21.05.2026.

Sunteti programat in data: 21 Mai 2026 ora: 09:10

Indicatie de revenire pentru internare:

- ☒ da, revine pentru internare in termen de 4 saptamani
- ☐ nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicala, caz in care se va inscrie seria si numarul acesteia
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz in care se va inscrie seria si numarul acestuia
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

Pentru programari sunati la urmatoarele numere: fix , mobil in programul in zilele lucratoare sau transmiteti un e-mail la cu precizarea numarului de telefon de contact.

Pentru urgente sunati la 112 sau va prezentati la cel mai apropiat centru de primiri urgente.

Medic curant
Semnatura, parafa

Calea de transmitere:

X - prin asigurat

- prin

posta

Semnatura pacient:

.....